



GUIA PARA PACIENTES

Dor na lateral do quadril

bursite ou tendinopatia glútea? o que a ciência diz e o que você pode fazer em casa

Por que o lado de fora do quadril dói ao deitar de lado e ao subir escada, o que tira a pressão do tendão e quais sinais pedem avaliação logo.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **QUADRIL**

Para quem é:

Para quem sente dor **no lado de fora do quadril**, em cima do "osso saliente" da lateral da coxa, que piora ao **deitar de lado**, subir escada, levantar da cadeira ou ficar muito tempo em pé, **sem queda ou batida** e **sem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem tem prótese no quadril ou operou o quadril: siga a orientação da sua equipe.
- Quem sente a dor principalmente **na virilha**, ou dor que **desce abaixo do joelho com formigamento**. Esses padrões apontam para outras causas (Página 5).

O que você vai precisar:

- Um cinto ou uma faixa elástica.
- Um ou dois travesseiros.
- Uma cadeira firme, de altura normal.
- Uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

O tendão gosta de **carga na medida certa** e não gosta de **ser apertado**.

Exercício com incômodo leve: sim. Posições que "esmagam" a lateral do quadril: não (Página 7).

A maioria das dores na lateral do quadril não é grave. Mas existe uma minoria que é, e ela tem sinais. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Vá ao pronto-socorro HOJE se:

- Depois de uma **queda**, mesmo da própria altura, você **não consegue apoiar o peso** na perna ou andar, ou a perna ficou **mais curta ou virada para fora**. Em pessoas mais velhas, com ossos frágeis, isso muitas vezes é **fratura** do fêmur ou da bacia [11].
- A dor vem com **febre** ou calafrios, ou a região está **quente, vermelha e inchada**. É preciso descartar infecção (opinião clínica).

Procure avaliação em poucos dias se:

- A dor é **principalmente na virilha**, com rigidez ou **dificuldade para calçar meia e sapato**. Isso sugere problema **dentro** da articulação, como a artrose [7][10].
- Você já teve **câncer**, mesmo há anos, ou está **perdendo peso sem querer** (opinião clínica).
- A dor noturna é **forte, constante e não alivia em nenhuma posição**. Doer ao deitar **sobre** o lado dolorido é típico da tendinopatia [7]; dor que não cede com nada merece investigação (opinião clínica).
- A dor **desce abaixo do joelho** com formigamento, dormência ou fraqueza: a causa pode estar na coluna (Página 5).

Observação honesta: nenhum desses sinais, sozinho, prova doença grave. Eles servem para dizer **quem precisa ser examinado antes**.

Os tendões do glúteo

Na lateral do quadril, dois músculos, o **glúteo médio** e o **glúteo mínimo**, prendem-se por tendões no **trocânter**, o osso saliente do lado da coxa. São eles que mantêm a bacia nivelada a cada passo. Perto deles ficam pequenas bolsas de deslizamento, as **bursas**.

Por que o nome mudou

Por décadas, esse quadro foi chamado de **bursite trocantérica**. Os exames de imagem contaram outra história: em 877 ultrassons de pessoas com essa dor, cerca de **metade tinha alteração nos tendões e 8 em cada 10 não tinham bursite** [5]. Uma série menor, com ressonância, mostrou o mesmo padrão [6].

Hoje, o tendão é visto como a **principal fonte** da dor. Os nomes usados são **tendinopatia glútea** ou **síndrome dolorosa do grande trocânter** [3][4].

Por que dói

O tendão sofre mais com a soma de **carga e compressão**. Quando a coxa cruza para dentro, em direção à outra perna, o tendão é **apertado contra o osso** [3]. Por isso dói deitar de lado, cruzar as pernas e ficar em pé apoiado num quadril só.

Quem tem

É mais comum em **mulheres entre 40 e 60 anos**, sobretudo após a menopausa [4][7]. Num estudo com adultos de 50 a 79 anos, cerca de **1 em cada 4 mulheres** tinha sinais do problema [8].

"Dor no quadril" pode vir de lugares diferentes, e o tratamento de cada um é diferente. Separar é a primeira tarefa da avaliação.

Tendão (tendinopatia glútea)

Dor **na lateral**, em cima do osso, que dói ao apertar. Piora ao deitar sobre o lado, subir escada e ficar em pé numa perna só. Calçar meia e sapato costuma ser fácil [7].

Articulação (artrose do quadril)

A dor que vem de dentro da articulação costuma aparecer na **virilha**, na nádega e na coxa [10]. Rigidez e **dificuldade para calçar meia e sapato** são comuns [7].

Coluna lombar

Dor que nasce nas costas ou na nádega e pode **descer pela perna**, às vezes com formigamento. A confusão é frequente: entre pacientes encaminhados a especialistas de coluna por dor lombar, cerca de **1 em cada 5** tinha, na verdade, a síndrome do trocânter. Mais da metade deles já tinha feito ressonância [9].

Podem coexistir

A síndrome do trocânter é mais frequente em quem também tem dor lombar ou artrose do joelho [8]. Ter um problema não exclui o outro.

E os exames?

O raio-X costuma ser o primeiro exame, para olhar a articulação [7]. A ressonância mostra alterações também em quem não sente dor: o laudo só tem valor junto com o exame físico [7].

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso se decide na consulta.

O estudo LEAP

Na Austrália, 204 pessoas com tendinopatia glútea confirmada por ressonância foram sorteadas para três caminhos: **educação + exercício** com fisioterapeuta por 8 semanas, **uma infiltração** de corticoide ou **esperar para ver** [1].

- **Em 8 semanas**, relataram melhora cerca de **8 em cada 10** no grupo educação + exercício, **6 em 10** na infiltração e **3 em 10** na espera.
- **Em 1 ano**, educação + exercício seguiu à frente na melhora global: cerca de 8 em 10, contra 6 em 10 e 5 em 10. Mas a **intensidade da dor** ficou parecida com a da infiltração.

Infiltração

Alívio mais rápido, porém **passageiro**: em outro estudo, a vantagem vista em 3 meses desapareceu em 1 ano [12][14]. Quando indicada, serve para **abrir uma janela** de menos dor para o exercício (opinião clínica).

Ondas de choque

Evidência **variável**: uma metanálise viu alívio entre 2 e 4 meses, com estudos de alto risco de viés [15]; outra não achou diferença significativa contra o controle [16].

Uma honestidade necessária

Em mulheres após a menopausa, exercício para o glúteo **não superou um exercício "falso"** quando os dois vinham com boa orientação; ambos melhoraram [17]. A orientação pesa muito, e nenhum tratamento é garantia.

Tirar a compressão é parte do tratamento. No LEAP, o grupo que mais melhorou recebeu **orientação sobre a carga no tendão** junto com o exercício [1].

Evite

- **Cruzar as pernas**, sentado ou em pé [7][18].
- **Ficar em pé "pendurado" num quadril só**, com o peso todo numa perna e a bacia caída para o lado. Distribua o peso nas duas pernas [18].
- **Deitar sobre o lado dolorido** [7].
- **Deitar sobre o lado bom sem travesseiro entre os joelhos**: a perna de cima cai para dentro e aperta o tendão [3][7].
- **Alongar a lateral da coxa** puxando a perna por cima da outra [7].
- Cadeiras e sofás **muito baixos**, em que o joelho fica acima do quadril (opinião clínica).

Para dormir

- **De lado, sobre o lado bom**, com **um ou dois travesseiros entre os joelhos** [7][18].
- **De barriga para cima**, com um travesseiro sob os joelhos, se for mais confortável (opinião clínica).

Tirar a compressão **não é ficar parado**. No LEAP, quem só esperou melhorou menos [1]. O movimento certo está na próxima página.

Inspirados nos primeiros níveis do programa do estudo LEAP [2]. A montagem exata é adaptação prática (opinião clínica).

Exercício 1 — Isometria de abertura, deitado

Como fazer: de barriga para cima, pernas esticadas e um pouco afastadas, com o cinto ao redor delas, acima dos tornozelos. Empurre as pernas **para fora** contra o cinto, **sem movê-las**, com força leve. Segure 5 a 10 segundos e solte. 5 a 10 vezes.

Sensação correta: esforço na lateral do quadril, sem aumentar a dor.

Erro comum: força máxima ou prender a respiração.

Exercício 2 — Isometria de abertura, em pé

Como fazer: de frente para uma bancada, mãos apoiadas, peso **igual nas duas pernas**. Pressione os pés para fora contra o chão, como se fosse afastá-los, **sem deslizar**. Segure 5 a 15 segundos. 5 a 10 vezes.

Sensação correta: os glúteos "acendem" dos dois lados.

Erro comum: inclinar o tronco ou deixar a bacia cair para um lado.

Exercício 3 — Ponte

Como fazer: deitado, joelhos dobrados, pés no chão na largura do quadril. Suba o quadril até alinhar com o tronco e desça devagar. 10 vezes.

Sensação correta: esforço no glúteo, não na lombar.

Erro comum: arquear as costas ou deixar os joelhos caírem para dentro.

Regra da dor

Durante o exercício, dor até **5 em 10** é aceitável, desde que **volte ao seu normal até a manhã seguinte**. Piorou no dia seguinte? Reduza na próxima sessão. *O limite de 5 em 10 veio do programa do LEAP [2]; a regra da "manhã seguinte" é orientação prática.*

Semanas 1 e 2 — Acalmar

- Página 7 todos os dias.
- Exercícios 1, 2 e 3, uma a duas vezes ao dia, com carga leve.

Semanas 3 a 8 — Progredir

- Aumente **uma coisa por vez**: tempo de isometria, repetições ou dificuldade.
- Se a regra da dor permitir, acrescente **sentar e levantar da cadeira** devagar e **passos laterais**, que fazem parte das fases seguintes do programa [2].

No LEAP, o programa durou 8 semanas, com fisioterapeuta [1]. Os volumes acima são ponto de partida, não protocolo testado.

Rastreador (1 vez por semana)

	Dor média no dia (0–10)	Dor ao subir escada (0–10)	Noites que acordou pela dor	Dias de exercício
Semana 1				
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				
Semana 6				
Semana 8				

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina. **Leve esta tabela para a consulta.**

1. Chamar tudo de "bursite" e tratar só a bursa.

Na maioria das pessoas, o problema está no tendão [5][6]. O tratamento de base é carga certa e menos compressão [3].

2. Alongar a lateral da coxa e usar rolinho com força em cima do osso.

Alongar cruzando a perna aumenta a compressão do tendão [7]. Rolinho com força sobre o osso segue a mesma lógica (opinião clínica).

3. Ficar parado "até passar".

Esperar sem fazer nada teve o pior resultado no LEAP em 8 semanas [1].

4. Tratar a infiltração como a solução.

O efeito costuma ser curto [12][13][14]. Num estudo com seguimento de 15 meses, quem fez só a infiltração teve menos sucesso do que quem fez exercício em casa [13].

5. Exercício demais, cedo demais.

Pular etapas e fazer muitas repetições com peso logo no início tende a irritar o tendão (opinião clínica). Use a regra da dor da Página 9.

Bônus: desistir em duas semanas. O programa do LEAP durou 8 semanas [1]. O rastreador ajuda a enxergar a tendência.

Procure avaliação médica se:

- Não há **melhora clara após 6 a 8 semanas** de cuidado bem feito. Esse prazo é bom senso clínico, coerente com a duração do programa do LEAP [1].
- A **dor noturna** não deixa dormir na maioria das noites.
- Você passou a **mancar** ou sente o quadril "falhar" ao andar (opinião clínica).
- Você não sabe se a dor vem do tendão, da articulação ou da coluna (Página 5).
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico**: o ponto exato da dor, testes que comprimem e que carregam o tendão [3], o movimento do quadril e o exame da coluna e dos nervos da perna. O objetivo é **diferenciar tendinopatia, artrose do quadril e dor lombar**, porque o tratamento de cada uma é diferente. Só depois se decide se há necessidade de exame e qual é o tratamento. A cirurgia fica reservada para poucos casos que não melhoram com o tratamento bem feito [3].

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Mellor R, Bennell K, Grimaldi A, Nicolson P, Kasza J, Hodges P, Wajswelner H, Vicenzino B. **Education plus exercise versus corticosteroid injection use versus a wait and see approach on global outcome and pain from gluteal tendinopathy: prospective, single blinded, randomised clinical trial.** BMJ. 2018;361:k1662. doi:10.1136/bmj.k1662. PMID: 29720374.
2. Mellor R, Grimaldi A, Wajswelner H, Hodges P, et al. **Exercise and load modification versus corticosteroid injection versus 'wait and see' for persistent gluteus medius/minimus tendinopathy (the LEAP trial): a protocol for a randomised clinical trial.** BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:196. doi:10.1186/s12891-016-1043-6. PMID: 27139495.
3. Grimaldi A, Mellor R, Hodges P, Bennell K, Wajswelner H, Vicenzino B. **Gluteal tendinopathy: a review of mechanisms, assessment and management.** Sports Med. 2015;45(8):1107-1119. doi:10.1007/s40279-015-0336-5. PMID: 25969366.
4. Grimaldi A, Fearon A. **Gluteal tendinopathy: integrating pathomechanics and clinical features in its management.** J Orthop Sports Phys Ther. 2015;45(11):910-922. doi:10.2519/jospt.2015.5829. PMID: 26381486.
5. Long SS, Surrey DE, Nazarian LN. **Sonography of greater trochanteric pain syndrome and the rarity of primary bursitis.** AJR Am J Roentgenol. 2013;201(5):1083-1086. doi:10.2214/AJR.12.10038. PMID: 24147479.
6. Bird PA, Oakley SP, Shnier R, Kirkham BW. **Prospective evaluation of magnetic resonance imaging and physical examination findings in patients with greater trochanteric pain syndrome.** Arthritis Rheum. 2001;44(9):2138-2145. PMID: 11592379.
7. Speers CJ, Bhogal GS. **Greater trochanteric pain syndrome: a review of diagnosis and management in general practice.** Br J Gen Pract. 2017;67(663):479-480. doi:10.3399/bjgp17X693041. PMID: 28963433.
8. Segal NA, Felson DT, Torner JC, Zhu Y, et al. **Greater trochanteric pain syndrome: epidemiology and associated factors.** Arch Phys Med Rehabil. 2007;88(8):988-992. doi:10.1016/j.apmr.2007.04.014. PMID: 17678660.
9. Tortolani PJ, Carbone JJ, Quartararo LG. **Greater trochanteric pain syndrome in patients referred to orthopedic spine specialists.** Spine J. 2002;2(4):251-254. doi:10.1016/s1529-9430(02)00198-5. PMID: 14589475.
10. Leshner JM, Dreyfuss P, Hager N, Kaplan M, Furman M. **Hip joint pain referral patterns: a descriptive study.** Pain Med. 2008;9(1):22-25. doi:10.1111/j.1526-4637.2006.00153.x. PMID: 18254763.
11. Ross AB, Lee KS, Chang EY, Amini B, et al; Expert Panel on Musculoskeletal Imaging. **ACR Appropriateness Criteria® Acute Hip Pain-Suspected Fracture.** J Am Coll Radiol. 2019;16(5S):S18-S25. doi:10.1016/j.jacr.2019.02.028. PMID: 31054744.
12. Brinks A, van Rijn RM, Willemsen SP, Bohnen AM, et al. **Corticosteroid injections for greater trochanteric pain syndrome: a randomized controlled trial in primary care.** Ann Fam Med. 2011;9(3):226-234. doi:10.1370/afm.1232. PMID: 21555750.
13. Rompe JD, Segal NA, Cacchio A, Furla JP, et al. **Home training, local corticosteroid injection, or radial shock wave therapy for greater trochanter pain syndrome.** Am J Sports Med. 2009;37(10):1981-1990. doi:10.1177/0363546509334374. PMID: 19439758.
14. Barratt PA, Brookes N, Newson A. **Conservative treatments for greater trochanteric pain syndrome: a systematic review.** Br J Sports Med. 2017;51(2):97-104. doi:10.1136/bjsports-2015-095858. PMID: 27834675.
15. Rhim HC, Shin J, Beling A, Guo R, et al. **Extracorporeal shockwave therapy for greater trochanteric pain syndrome: a systematic review with meta-analysis of randomized clinical trials.** JBJS Rev. 2024;12(8). doi:10.2106/JBJS.RVW.24.00091. PMID: 39297780.
16. Harding D, Cameron L, Monga A, Winter S. **Is shockwave therapy effective in the management of greater trochanteric pain syndrome? A systematic review and meta-analysis.** Musculoskeletal Care. 2024;22(2):e1892. doi:10.1002/msc.1892. PMID: 38777616.
17. Ganderton C, Senciw A, Cook J, Moreira E, et al. **Gluteal loading versus sham exercises to improve pain and dysfunction in postmenopausal women with greater trochanteric pain syndrome: a randomized controlled trial.** J Womens Health (Larchmt). 2018;27(6):815-829. doi:10.1089/jwh.2017.6729. PMID: 29715073.
18. Høgstølt M, Kierkegaard-Brøchner S, Lange J, Lund B, et al. **Physiotherapist-led education and exercise for patients with MRI-verified hip abductor tendon pathology: a prospective cohort study.** BMJ Open. 2026;16(9):e120837. doi:10.1136/bmjopen-2026-120837. PMID: 42727969.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

